

NEOSLEEP

— TU DESCANSO, EN UNA NUEVA ERA —

PROTOCOLO DE ATENCIÓN

EN PACIENTES CON APNEA DEL SUEÑO

LORENA ALEJANDRA GONZÁLEZ PIMENTEL

Esta semana probablemente
viste pacientes con
APNEA OBSTRUCTIVA
DEL SUEÑO
y no lo supiste.

Entonces la pregunta es...

¿Cómo el dentista puede detectarla?

ANTECEDENTES MÉDICOS



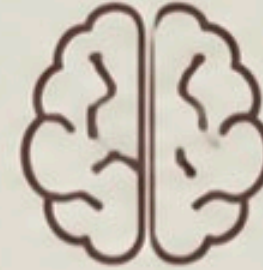
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

- Hipertensión arterial y pulmonar
- Arritmias
- Cardiopatía isquémica
- Insuficiencia cardíaca
- Tromboembolismo pulmonar



EFFECTOS METABÓLICOS

- Resistencia a la insulina
- Diabetes mellitus
- Síndrome metabólico



EFFECTOS NEUROCOGNITIVOS

- Demencia
- Depresión



EFFECTOS NEOPLÁSICOS

- Cáncer

PREGUNTAS SIMPLES

CUESTIONARIO STOP-Bang

S



Snoring

¿Ronca fuerte?

T



Tiredness

¿Se siente cansado, fatigado o somnoliento durante el día?

O



Observed Apnea

¿Alguien ha observado que deja de respirar mientras duerme?

P



Pressure

¿Tiene o está en tratamiento por presión arterial alta?

B



BMI > 35 kg/m²

¿Tiene un índice de masa corporal mayor a 35?

A



Age > 50 años

¿Tiene más de 50 años?

N



Neck circumference

¿Tiene circunferencia de cuello mayor a 40 cm?

G



Gender (Male)

¿Es hombre?

PUNTUACIÓN TOTAL



0 – 8 PUNTOS

(Suma total)

INTERPRETACIÓN DEL RIESGO



**0 – 2 puntos
BAJO RIESGO**

Probabilidad baja de AOS



**3 – 4 puntos
RIESGO INTERMEDIO**

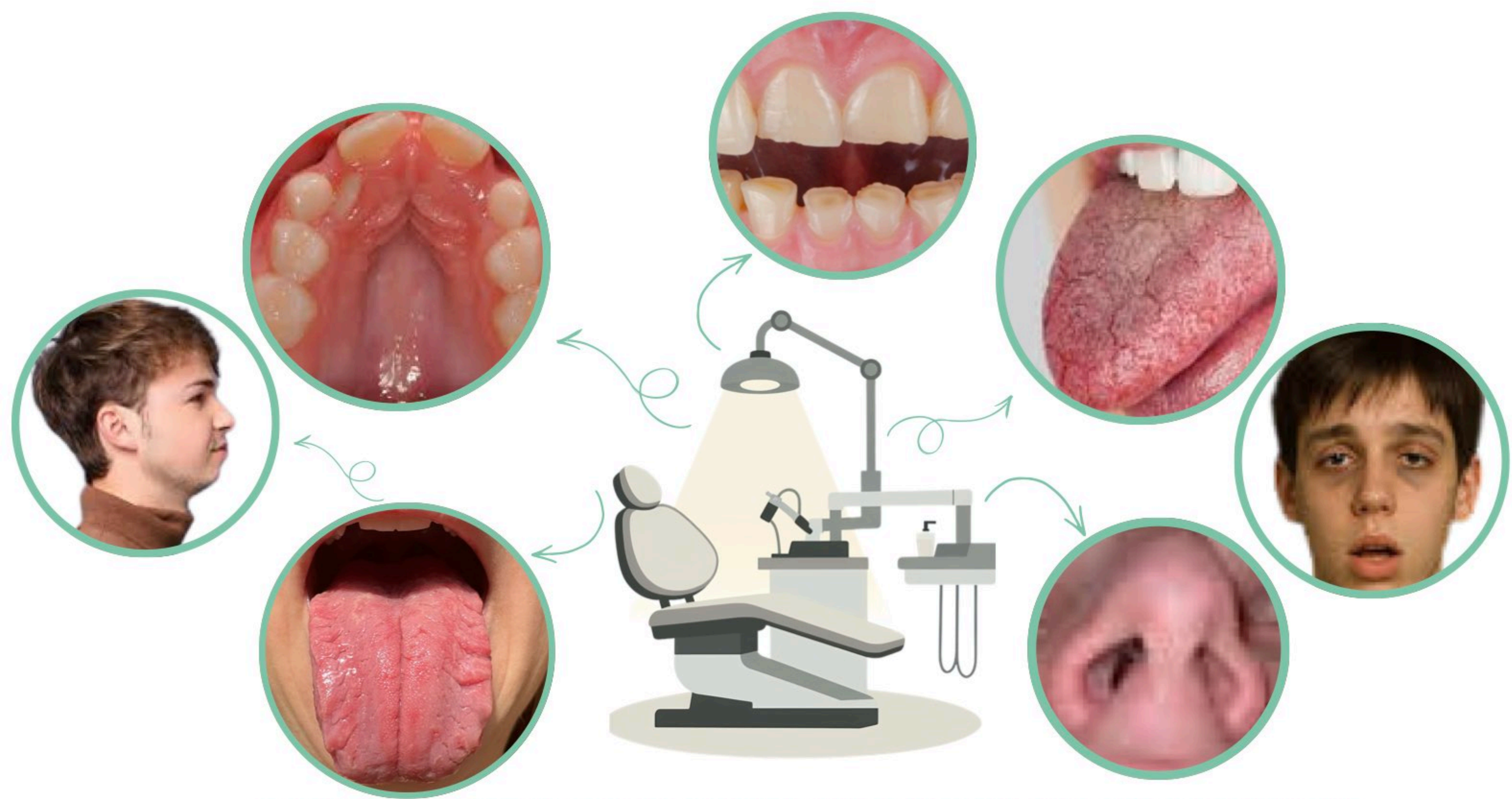
Probabilidad moderada de AOS



**5 – 8 puntos
ALTO RIESGO**

Probabilidad alta de AOS

¿Qué debemos
observar
clínicamente?



STANDARDS FOR PRACTICE COMMITTEE OF THE AMERICAN ACADEMY OF DENTAL SLEEP MEDICINE: MITCHELL LEVINE,

Perfil Clínico del **Paciente**



Indicado para



Apnea obstructiva
del sueño de
leve a **moderada**.



Intolerancia
a CPAP.



Ronquido
crónico significativo.



Contraindicado en



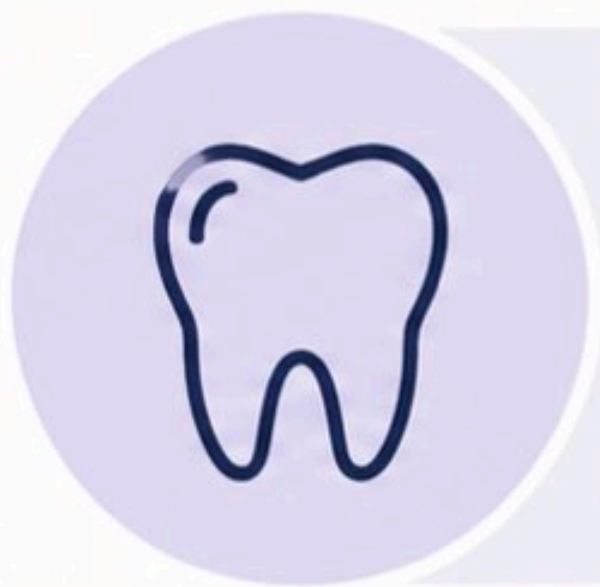
Enfermedades
respiratorias severas.



Enfermedad
periodontal avanzada.

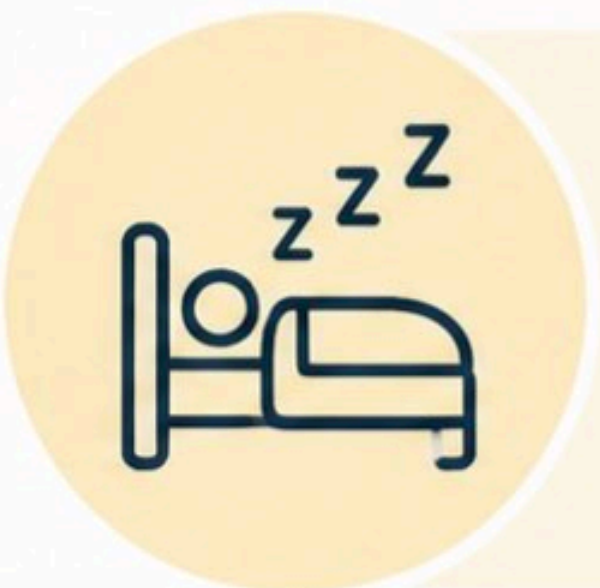


Apnea central
del sueño.



ODONTÓLOGO

Identifica signos y factores de riesgo en la consulta dental.



POLISOMNOGRAFÍA

Confirma el diagnóstico y determina la severidad del AOS.



NEUMÓLOGO

Realiza el diagnóstico integral y define el tratamiento.



PROTOCOLO DE ATENCIÓN

EN LA CONSULTA ODONTOLÓGICA

1

PRIMERA CITA

Valoración y estudio Biologix



2

SEGUNDA CITA

Escáner bucal



3

TERCERA CITA

Entrega, adaptación y colocación del DAM



4

CUARTA CITA

Control a las 2 semanas



5

QUINTA CITA

Control + siguiente avance
2 semanas después



PRIMERA CITA | VALORACIÓN Y ESTUDIO BIOLOGIX

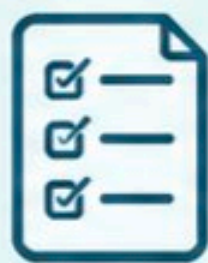
DEL DIAGNÓSTICO AL TRATAMIENTO, PASO A PASO

1



Historia clínica
NeoSleep.

2



Cuestionario
y valoración
inicial.

3



Explicación
del estudio
de sueño.

4



Entrega del
Biologix.

5



Descarga de la app
Biologix y vinculación
del dispositivo por
Bluetooth.



6



El paciente utiliza
el equipo durante
3 noches.

7



NeoSleep recibe
los resultados mediante
la plataforma.

8



Los resultados se envían
al neumólogo para
su análisis.

9



El neumólogo determina
si el paciente es
candidato a DAM.

ENTREGAS / ACCIONES



Biologix + app Biologix



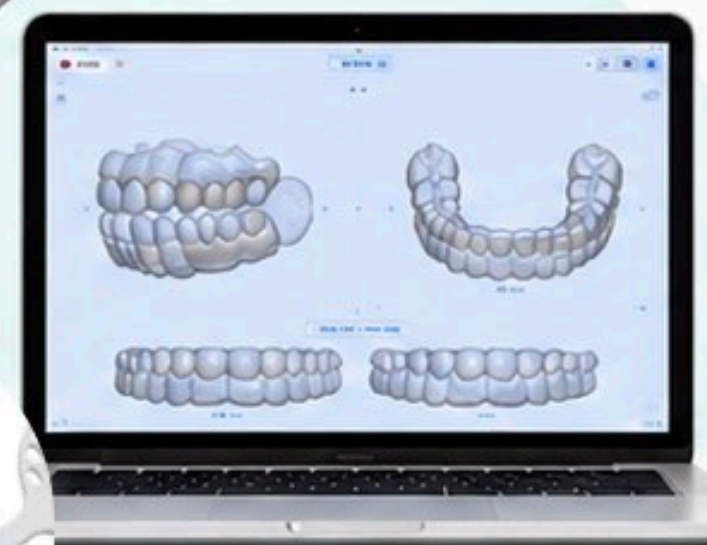
3 noches de uso



Resultados a neumólogo

2

SEGUNDA CITA Escáner bucal



1

El paciente entrega el sensor Biologix.



2

Escaneo de maxilar superior, maxilar inferior y oclusión céntrica.



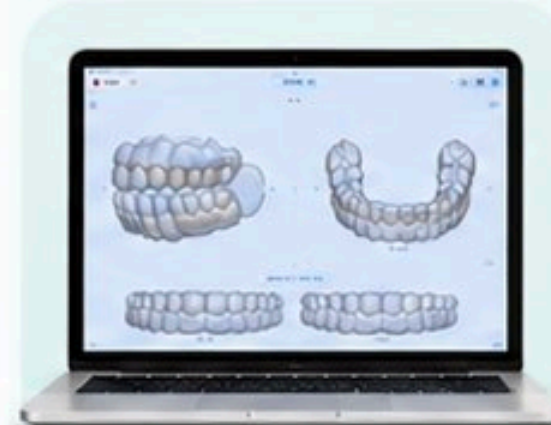
3

Registro del avance mandibular con George Gauge.



4

Carga de archivos STL y datos del paciente.



5

Confirmación de recepción por correo.



6

El laboratorio informa la fecha de entrega del DAM (15 días aprox.).



Descargar la app RoncoLab y comenzar registros 3 noches antes de la entrega del DAM.

Registro de mordida para dispositivo de avance mandibular

1

Medir el rango de avance mandibular con la Galga de George



Protrusión

Deslizar la mandíbula hacia delante sin que se salgan los dientes de la rejilla.

Anotar la medida (MP)



Retrusión

Deslizar la mandíbula hacia atrás sin que se salgan los dientes de la rejilla.

Anotar la medida (MR)

MR Retrusión
0 mm

MP Protrusión
6–7 mm

2

Verificación de la medida



Retirar la galga y posicionarla nuevamente con la medida protrusiva.

Confirmar que el paciente no presente dolor articular o molestia.



El paciente debe sentirse cómodo, sin dolor articular.

3

Registro de mordida con masilla en protrusión



Colocar la masilla de registro en la galga con la medida protrusiva.



Esperar a que endurezca y retirar de boca.



4

Escaneo intraoral sin la galga



Escanear toda la boca del paciente sin la galga.



5

Escaneo intraoral con el registro en protrusión



Colocar nuevamente la galga con el registro de mordida. El paciente debe ocluir tal cual en protrusión como se realizó el registro.

Escanear con la galga y el registro en boca.



Siempre confirmar la comodidad del paciente y ausencia de dolor articular con la medida en protrusión.

3

TERCERA CITA

Entrega, adaptación y colocación del DAM

DEL DIAGNÓSTICO AL TRATAMIENTO,
PASO A PASO



ENTREGAS / ACCIONES



DAM + dispositivos de avance



Indicaciones al paciente



App RoncoLab
(3 noches con DAM)

1

Entrega del dispositivo de avance mandibular.



2

Adaptación y verificación en boca.



3

Explicación de uso, colocación, retiro, higiene y cuidado.



4

Entrega de los dispositivos para los diferentes niveles de avance (según autorización del doctor).



5

Por 3 noches: registros con RoncoLab utilizando el DAM.



4

CUARTA CITA

Control a las 2 semanas

DEL DIAGNÓSTICO AL TRATAMIENTO,
PASO A PASO



EN ESTA CITA



Evaluación clínica



Ajustes si es necesario



Indicar siguiente avance
(si está indicado)

1

Evaluación de adaptación y comodidad.



2

Preguntar por síntomas, sueño, ronquido y tolerancia.



3

Revisar evolución del paciente.



4

Valorar posibles molestias articulares, musculares o oclusales.



5

Según evolución y autorización del odontólogo, indicar si puede pasar al siguiente nivel de avance.



SEGUIMIENTO CON APP RONCOLAB

¿Cómo sabemos si es necesario pasar al siguiente dispositivo de avance mandibular?



1

Uso del primer dispositivo

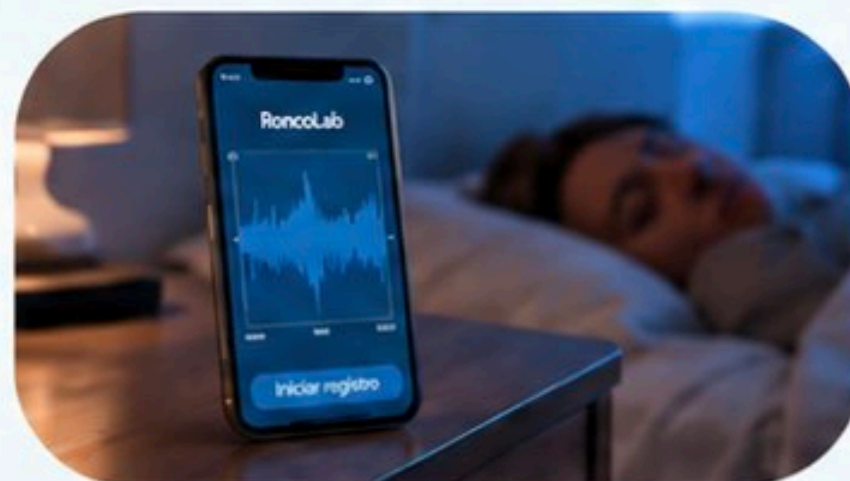
El paciente utiliza el primer dispositivo con el primer avance mandibular durante 2 semanas.



2

Registro con RoncoLab

El paciente realiza registros de sueño en casa, utilizando la app RoncoLab con el Roncómetro durante varias noches al final de las 2 semanas.



3

Análisis de resultados

Resultados del Roncometro



Índice de ronquido
15
eventos/hora

Intensidad media
42
dB

Tiempo de ronquido
8%
de la noche

4

Decisión clínica

Si los parámetros del Roncómetro indican que el paciente continúa roncando, se indicará el siguiente dispositivo de avance mandibular (con mayor avance) según el protocolo del tratamiento.



Dispositivo actual
Primer avance



Siguiente dispositivo
Mayor avance

Articulares, musculares y oclusales

P A S O A P A S O

1

Terapia de calor



Compresas tibias en ATM y músculos



15–20 min
2–3 veces al día



2

Masaje en la zona del ATM



Masaje suave en ATM y músculos masticatorios



5–10 min
2–3 veces al día



3

Manejo farmacológico



Analgésicos y/o relajantes musculares (según indicación)



4

Periodo de manejo



Mantener indicaciones durante 10 días



5

Evaluación clínica



- ✓ Dolor
- ✓ Función mandibular
- ✓ Molestias musculares
- ✓ Relación oclusal



6

Decisión sobre el siguiente paso



- ✓ Continuar tratamiento
- ✓ Realizar ajustes
- ✓ Considerar estudios adicionales



5

QUINTA CITA

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Control y siguiente avance

2 SEMANAS DESPUÉS

1

Evaluación clínica



Síntomas y comodidad



Revisión articular, muscular y oclusal



2

Revisión de resultados



Análisis con app RoncoLab



3

Decisión del siguiente avance



Autorizar avance mandibular (si los parámetros mejoran)



4

Entrega del nuevo dispositivo



Uso e indicaciones



5

Continuidad del tratamiento



Usar 2 semanas y mantener registros



MENOS RONQUIDO



MEJOR RESPIRACIÓN



MÁS ENERGÍA



UNA MEJOR VIDA

NUEVO ESTUDIO BIOLOGIX

¿Cuándo es necesario realizar un nuevo estudio con Biologix?

PARA VALORAR LA EVOLUCIÓN DEL TRATAMIENTO

1

Nuevo estudio Biologix



Al finalizar tratamiento

2

Uso del dispositivo



3 noches en casa

3

Resultados del estudio



Índices de apnea



Carga hipóxica



Riesgo cardiovascular



4

Análisis por el neumólogo



Revisión de resultados

5

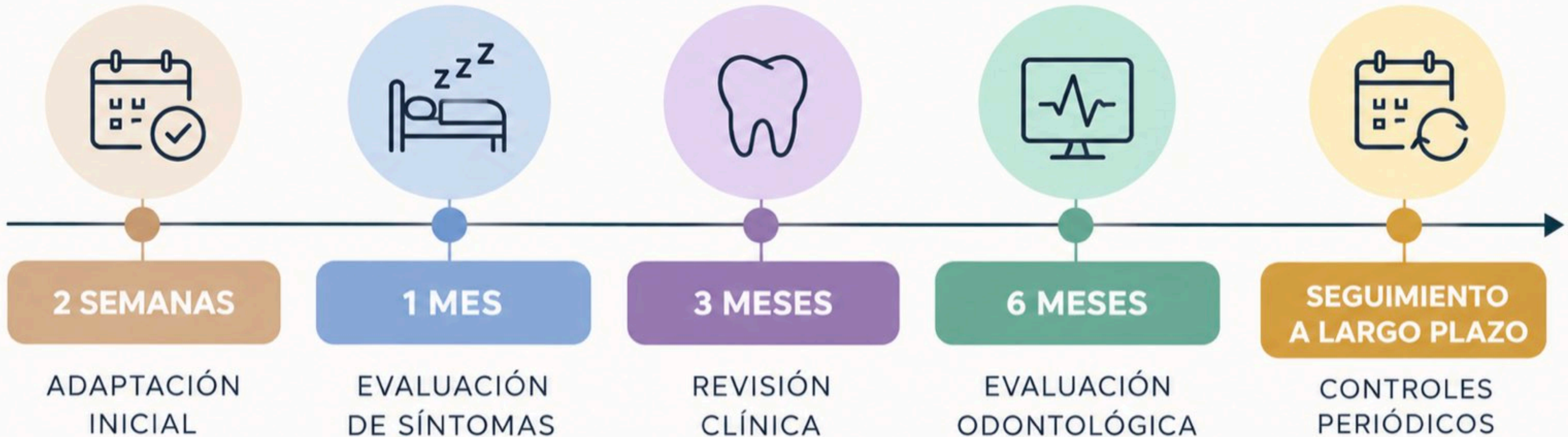
Autorización y alta del paciente



Autorización del neumólogo



ADAPTACIÓN Y SEGUIMIENTO



LA APNEA DEL SUEÑO
PUEDE CAMBIAR LA VIDA DEL PACIENTE,
Y **EL DENTISTA** PUEDE SER QUIEN
LO DETECTE PRIMERO

La pregunta no es si tienes
pacientes con apnea,
**sino qué estás haciendo
con ellos**

¡Gracias por su atención!

lorena.gonzalez@neosleepcare.com